



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : كامله احمد محمد على
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الصف
العنوان : 0
رقم البطاقة : 26712272100665 رقم التليفون : 01146628251
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-12-1967 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي Anthracyclines base
قسم العلاج :
الأورام

[14151]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كامله احمد محمد علي National ID: 26712272100665	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Anthracycline-based chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠١٥/٣ ٢٦٧١٢٢٧٢١٠٠٦٦٥

النش مملعة ارملة



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٣/٢١



جمهورية مصر العربية
بطاقة طبق الشخصية

كامله

احمد محمد على

نزلة عليان

مركز الصفا - الجيزة

١٩٦٧/١٢٨٧

٢٦٧ ١٢ ٢٧ ٢١ ٠٠٦ ٦٥

GA4755487

٢٠١٥/٣
مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سي)

٢٠١٥/٣



DMS
مفوضية
تدعيم

السوق عد السيسر

Name: <u>كامله احمد محمد على</u>		
MR. : <u>11550</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 59-year-old individual with a right breast mass diagnosed as invasive ductal carcinoma (IDC) that is HER2-enriched and hormone receptor-negative. Clinical staging at presentation was T4B N3A Mx, with CT of the chest, abdomen, and pelvis requested for further evaluation. The patient has a history of hypertension managed with medications. At the time of the oncology assessment, the right breast IDC was graded G2, ER/PR negative, HER2 3+, and staged as cT4D N3M0. Physical examination revealed skin thickening, periareolar and nipple retraction, and peau d'orange with associated skin edema. A Port-acath was placed for neoadjuvant chemotherapy (NACT) consisting of 4 cycles of AC followed by 4 cycles of TCHP. Echocardiography and laboratory studies were pending at that time; the first cycle of AC was administered on the day of the note. The pharmacy visit on 04/08/2026 documented the patient's weight at 84 kg and height at 159 cm, with an echocardiogram on 04/08/2026 showing an ejection fraction of 64 %. The visit was for the administration of cycle 1 of AC. The clinical pharmacy note on 24/08/2026 recorded the patient's serum albumin at 1.92 g/dL during cycle 2 of AC, with the patient receiving adriamycin 115 mg and endoxan 1150 mg. The patient has completed 2 cycles of AC to date.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	الطبيب المعالج : <u>ميّار فؤاد علي فؤاد</u>	
يعتمد ,		

Patient Name	كاملة احمد محمد على 0
Sex/Age	Female 58Y
Registered Date	23/05/2026 11:16:43
Validation Date	13/06/2026 10:47:47
Reporting Date	6/13/2026, 11:52:34 AM

Code Number	YK 262848
Patient ID	20071
Referred By Dr.	Out Patient
Branch	Gustave Roussy

BREAST and BIOMARKERS

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 23/05/2026, at 1:15pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma with focal mucinous differentiation
- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
- DCIS: Absent
- Microcalcification: Absent
- Angioinvasion: Absent
- Perineural invasion: Absent

Results:

- * IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8)
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 30%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 30%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC

Patient Name
Sex/Age
Registered Date
Validation Date
Reporting Date

0
Female 58Y
23/05/2026 11:16:43
13/06/2026 10:47:47
6/13/2026, 11:52:34 AM

Code Number
Patient ID
Referred By Dr.
Branch

YK 262848
20071
Out Patient
Gustave Roussy

0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Maha Guimei
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Maser El Qadima - Cairo, Egypt

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/.....

تحية طبية وبعد،

كامل
بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء لطلب المقدم من

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

Breast ca

AC

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

الطبيب المعالج

يُعتمد،،